

Bronquiolitis

1. Introducción y relevancia clínica

La **bronquiolitis aguda** es la **infección respiratoria baja más frecuente en lactantes menores de 2 años**, y constituye una de las principales causas de hospitalización pediátrica durante los meses de otoño e invierno. Se trata de una enfermedad viral autolimitada que afecta preferentemente a lactantes menores de 12 meses, especialmente en aquellos con antecedentes de **prematurez, cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar** o **inmunodeficiencias**, quienes presentan mayor riesgo de cuadros graves.

Su agente etiológico principal es el **virus respiratorio sincicial (VRS)**, responsable de más del 70% de los casos, aunque también pueden causarla el **virus parainfluenza, adenovirus, influenza** y **metapneumovirus humano**.

Desde el punto de vista clínico y del **EUNACOM**, la bronquiolitis se pregunta con frecuencia por ser una patología clásica en la práctica general y por requerir **diagnóstico clínico, manejo sintomático** y **criterios claros de hospitalización**.

2. Definición y fisiopatología

La bronquiolitis se define como el **primer episodio de dificultad respiratoria baja asociado a sibilancias o crepitaciones**, precedido por un cuadro catarral de vías altas, en un niño **menor de 2 años** (con mayor frecuencia entre los 3 y 6 meses).

El VRS infecta las células epiteliales de los bronquiolos terminales, produciendo **necrosis epitelial, hipersecreción de moco y edema de la mucosa**, lo que lleva a **obstrucción parcial o total de la luz bronquiolar**. Esto causa atrapamiento aéreo, atelectasias y alteración del intercambio gaseoso, generando hipoxemia y aumento del trabajo respiratorio.

El tamaño reducido de las vías respiratorias en lactantes explica por qué un mínimo edema produce una gran resistencia al flujo, agravando la clínica.

3. Epidemiología

- **Edad:** pico entre los 3 y 6 meses.
- **Estacionalidad:** brotes en **otoño e invierno** (abril a septiembre en el hemisferio sur).

- **Transmisión:** por gotas y contacto directo con secreciones infectadas; el virus puede sobrevivir horas en superficies.
- **Período de incubación:** 3 a 5 días.
- **Contagiosidad:** alta, especialmente en guarderías y salas cuna.

Factores de riesgo para enfermedad grave:

- Prematurez (<35 semanas).
 - Menor de 3 meses.
 - Cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa.
 - Displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica.
 - Inmunodeficiencia.
 - Tabaquismo pasivo o hacinamiento.
-

4. Clínica

El cuadro clínico tiene un inicio progresivo, en dos fases:

1. Fase catarral (48–72 horas):

- Rinorrea serosa.
- Congestión nasal.
- Tos irritativa.
- Fiebre baja o ausente.
- Disminución del apetito.

2. Fase respiratoria baja:

- Tos intensa.
- Taquipnea (primer signo de gravedad).
- Aumento del trabajo respiratorio: aleteo nasal, retracciones intercostales o subcostales, quejido espiratorio.
- Sibilancias y/o crepitaciones bilaterales.
- En casos moderados a graves, signos de hipoxemia: cianosis, quejido, apneas (especialmente en RN).

El examen físico revela hipersonoridad a la percusión, sibilancias difusas y prolongación del tiempo espiratorio. En cuadros graves puede observarse tiraje universal, quejido y pausas de apnea.

La evolución típica es de **7 a 10 días**, aunque la tos puede persistir hasta 3 semanas.

5. Diagnóstico

El diagnóstico de bronquiolitis es **clínico**, basado en la edad, el contexto epidemiológico y la clínica característica.

No se requieren exámenes complementarios de rutina.

Los exámenes se reservan para casos moderados o graves, o cuando existen dudas diagnósticas.

Exámenes posibles:

- **Oximetría de pulso:** imprescindible para evaluar la saturación de O₂ .
- **Radiografía de tórax:** solo si se sospecha neumonía, atelectasia o neumotórax; muestra hiperinsuflación, aplanamiento diafragmático e infiltrado intersticial.
- **Test viral rápido o PCR para VRS:** útil solo en contexto hospitalario o epidemiológico.

Diagnóstico diferencial:

- Asma (en niños mayores o con recurrencias).
 - Neumonía bacteriana.
 - Cuerpo extraño bronquial.
 - Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Coqueluche.
-

6. Clasificación de gravedad (MINSAL 2024)

- **Leve:** buen estado general, taquipnea leve, saturación >94%, alimenta bien.
 - **Moderada:** dificultad respiratoria evidente, tiraje leve a moderado, saturación 90–94%, rechazo parcial de alimentación.
 - **Grave:** tiraje universal, quejido, cianosis, apneas, saturación <90%, rechazo alimentario total o signos de agotamiento.
-

7. Manejo general

El manejo de la bronquiolitis es **sintomático y de soporte**, sin antivirales ni antibióticos, ya que la etiología es viral.

7.1. Manejo ambulatorio (cuadros leves)

- Mantener buena hidratación oral.
- Lavados nasales con suero fisiológico y aspiración de secreciones.
- Fraccionar la alimentación.
- Control de temperatura (paracetamol).

- Educación a cuidadores sobre signos de alarma (dificultad respiratoria, rechazo alimentario, apneas, cianosis).
- No usar broncodilatadores ni corticoides de rutina.

7.2. Manejo hospitalario (casos moderados o graves)

Criterios de hospitalización:

- Saturación <92%.
- Signos de dificultad respiratoria moderada a grave.
- Apneas o episodios de cianosis.
- Rechazo alimentario importante o deshidratación.
- Lactantes <3 meses o con comorbilidades.

Medidas hospitalarias:

- Oxigenoterapia (inicio con cánula nasal, objetivo $\text{SatO}_2 >94\%$).
- Hidratación IV o sonda nasogástrica si no tolera vía oral.
- Control térmico y monitoreo continuo de SatO_2 y FC.
- Posición semiincorporada para mejorar la ventilación.
- Aspiración suave de secreciones nasales.
- En casos de hipoxemia severa: ventilación no invasiva (CPAP) o intubación si hay signos de agotamiento.

No están recomendados:

- Broncodilatadores (salbutamol) → no mejoran evolución ni saturación.
- Corticoides → no modifican la evolución ni reducen hospitalización.
- Antibióticos → solo si hay sobreinfección bacteriana (fiebre alta, consolidación radiológica).
- Adrenalina nebulizada → solo uso puntual en urgencias en casos graves, mientras se evalúa respuesta.

8. Prevención

8.1. Medidas generales:

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.
- Lavado frecuente de manos.
- Evitar exposición al humo de tabaco.
- Evitar contacto con personas resfriadas.
- Ventilación adecuada de ambientes cerrados.

8.2. Inmunoprofilaxis:

Palivizumab (anticuerpo monoclonal anti-VRS) está indicado en:

- Prematuros <32 semanas.
- Niños con displasia broncopulmonar que requieren oxígeno.
- Cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas.

Se administra en 5 dosis mensuales durante la temporada epidémica.

9. Complicaciones

Aunque la mayoría de los casos son leves, pueden presentarse:

- Apneas recurrentes (en RN y prematuros).
- Neumonía secundaria.
- Atelectasias.
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Otitis media aguda asociada.
- Evolución hacia sibilancias recurrentes o asma postbronquiolitis.

La mortalidad es baja (<1%), pero aumenta significativamente en lactantes con factores de riesgo.

10. Pronóstico y seguimiento

El pronóstico es excelente en la mayoría de los pacientes, con recuperación completa en 1 a 2 semanas.

En lactantes con antecedente de prematurez o enfermedad pulmonar, puede persistir hiperreactividad bronquial.

Se recomienda control posterior al alta para evaluar resolución clínica y educar a los padres sobre prevención.

11. Perlas clínicas EUNACOM

1. El diagnóstico de bronquiolitis es **clínico**, no radiológico.
2. El agente causal más frecuente es el **virus respiratorio sincicial (VRS)**.
3. El manejo es **sintomático**, evitando antibióticos y broncodilatadores.
4. La saturación de O₂ <92% es el criterio más importante de hospitalización.
5. En lactantes pequeños con apneas, se debe monitorizar en UCI.
6. No confundir con asma: la bronquiolitis ocurre en menores de 2 años y es el **primer episodio de sibilancias**.

7. La prevención se basa en **medidas higiénicas y palivizumab en grupos de riesgo**.
-

12. Resumen final

- La bronquiolitis es una infección viral de vías respiratorias bajas, predominantemente causada por el VRS.
- Afecta principalmente a lactantes menores de 2 años, cursando con dificultad respiratoria y sibilancias.
- El diagnóstico es clínico, sin necesidad de exámenes en la mayoría de los casos.
- El manejo es sintomático, centrado en oxigenoterapia e hidratación.
- Los broncodilatadores, corticoides y antibióticos no están indicados.
- La hospitalización se reserva para casos con hipoxemia, apneas o dificultad respiratoria grave.
- El pronóstico es bueno, aunque puede haber recurrencia de sibilancias.
- La prevención se basa en medidas de higiene y uso de palivizumab en grupos de alto riesgo.